

| RÉCAPITULATIF MÉTHODOLOGIQUE · MODULES M5 + M6

Estimations de couverture

Ce que font les modules · Comment lire le résultat

CE QU'ILS FONT

Transformer des comptages bruts en **couverture** — la part des personnes qui *avaient besoin* d'un service et l'ont effectivement reçu.

DEUX PARTIES

M5 détermine la **population cible** (le plus difficile)

M6 la transforme en couverture et comble les années entre enquêtes

À GARDER EN TÊTE

Ce sont des **estimations à partir de données de routine** — utiles pour les tendances et les comparaisons, pas des chiffres nationaux officiels.

Ce que signifie « couverture »

La couverture répond à une question simple : **parmi toutes les personnes qui avaient besoin d'un service, quelle part l'a effectivement reçu ?**

Prenons les premières visites prénatales (ANC1). Si **10 000** femmes étaient enceintes dans un district et que **8 000** ont eu une visite ANC1, la couverture est $8\,000 \div 10\,000 = 80\%$.

La couverture est donc toujours une fraction :

couverture = le nombre servi ÷ le nombre qui en avait besoin

$$\text{Couverture des services} = \frac{\text{Population ayant reçu le service}}{\text{Population ayant besoin du service (population cible)}}$$

Le numérateur provient des données DHIS2 — volumes de services après correction qualité

Plusieurs options pour estimer le dénominateur

Le hic

Le chiffre du **haut** est facile — les 8 000 visites ANC1 viennent directement du SIGS ; c'est juste le comptage de services.

Le chiffre du **bas** est le plus dur : **personne ne compte combien il y a de femmes enceintes (ou de nourrissons)**. Aucune formation ne déclare « 10 000 femmes étaient enceintes ici cette année ».

Tout le travail de ces modules se ramène donc à une question — **où trouver ce chiffre du bas, la population cible ?** C'est ce que M5 cherche à estimer.

| M5 • ESTIMER LA POPULATION

Comment M5 trouve le chiffre du bas

Étape 1 — l'emprunter à une enquête. Tous les quelques ans, une enquête ménages mesure la couverture *directement*, en interrogeant les familles. Elle peut nous dire que, disons, **80 % des femmes enceintes ont eu l'ANC1**. Combinons avec le comptage que nous avons déjà : si les **8 000** visites ANC1 représentent 80 % de toutes les femmes enceintes, le total est $8\,000 \div 0,80 = 10\,000$ **femmes enceintes**. Nous avons retrouvé le chiffre du bas qu'on ne pouvait pas compter.

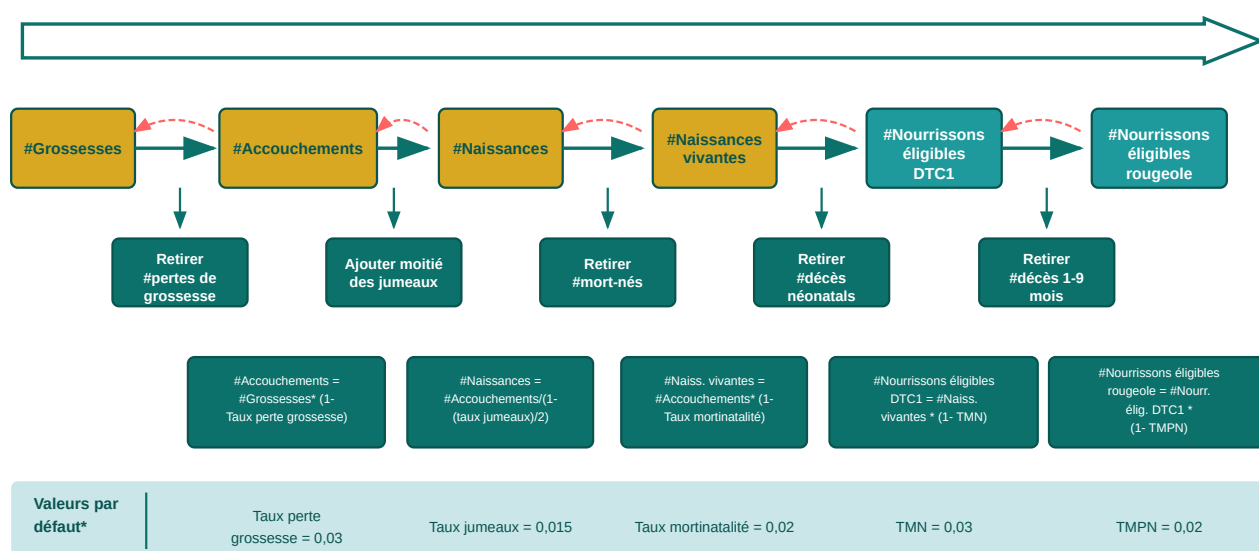
Étape 2 — l'ajuster au bon groupe. 10 000 femmes enceintes est le bon dénominateur pour les soins prénatals — mais le **Pental s'administre aux nourrissons**, un autre groupe. Pas besoin d'une seconde enquête : une grossesse *devient* une naissance *devient* un nourrisson, et on sait à peu près combien sont perdus à chaque étape. FASTR fait donc descendre le nombre — moins les fausses couches et mortinaissances, moins les décès néonataux — jusqu'à environ **9 100 nourrissons**. Une seule enquête donne alors le dénominateur de *chaque* indicateur.

Étape 3 — recouper, et choisir le meilleur. L'ANC1 n'est pas le seul point de départ ; les accouchements, le Pental et le BCG donnent chacun leur propre estimation de la population, et elles ne concordent pas toutes. Pour choisir, FASTR aligne chaque estimation sur la **projection de population de l'ONU** — un chiffre indépendant, bâti sans le SIGS — et garde celle qui s'en approche le plus.

La couverture ne vaut que son dénominateur. C'est pourquoi M5 ne se fie pas à un seul indicateur — il en triangule plusieurs et laisse la projection ONU indépendante départager.

| M5 · LA CHAÎNE DE LA VIE (ÉTAPE 2)

Des grossesses aux nourrissons



*L'approche FASTR utilise les valeurs spécifiques au pays pour le taux de mortalité, TMN, TMPN et TMI si disponibles via EDS/MICS

Les **flèches turquoise** vont vers l'*avant* — chacune applique un taux démographique standard (en retranchant les pertes de cette étape). Les **flèches rouges** vont *en arrière* : les mêmes taux permettent de **recalculer en sens inverse** la chaîne depuis n'importe quel point, donc FASTR peut partir de l'indicateur qui dispose d'une enquête (ANC1, accouchement, Penta1...) et atteindre quand même toutes les autres populations cibles.

M6 • LE RÉSULTAT

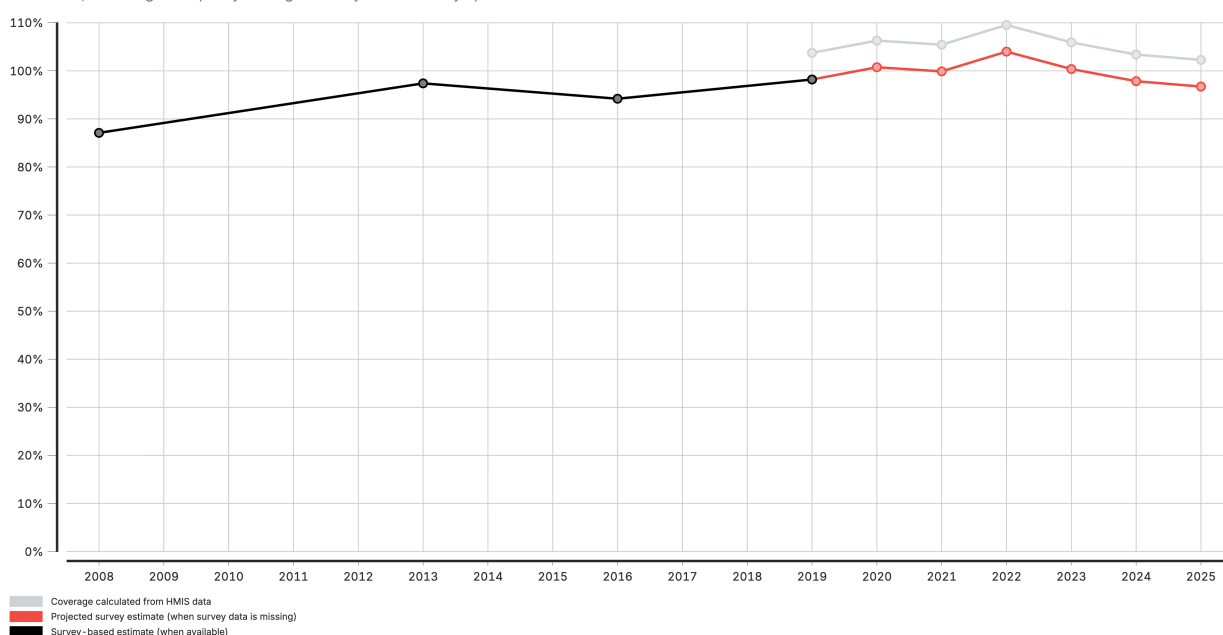
La couverture dans le temps

Maintenant le plus simple : **couverture = comptage SIGS ÷ cette population**, pour chaque indicateur, année et zone. Les enquêtes n'ont lieu que tous les quelques ans, donc entre elles FASTR conserve la dernière valeur d'enquête et la décale d'autant que la couverture SIGS a bougé — l'enquête fixe le **niveau**, le SIGS la **direction**.

Coverage estimates for Antenatal client 1st visit

2008 to 2025

DISCLAIMER: These results use routine data to provide rigorous, but not official estimates. They should be interpreted considering any data quality or representation limitations, including data quality findings and any other country specific factors.



Estimating service coverage from administrative data can provide more timely information on coverage trends, or highlight data quality concerns. Numerators are the volumes reported in HMIS, adjusted for data quality. Denominators are selected from UN projections, survey estimates, or derived from HMIS volume for related indicators. National projections are made by applying HMIS trends to the most recent survey data. Subnational estimates are more sensitive to poor data quality, and projections from surveys are not calculated.

MICS data courtesy of UNICEF. Multiple Indicator Cluster Surveys (various rounds) New York City, New York.

DHS data courtesy of ICF. Demographic and Health Surveys (various rounds). Rockville, Maryland.

Data for the current year reflect the period available at the time of analysis; population figures have been scaled to match the corresponding duration.

- **Les lignes — noir** = couverture SIGS (comptage ÷ population estimée), chaque année ; **points rouges** = résultats d'enquête réels ; **gris** = l'enquête projetée selon la tendance SIGS là où aucune enquête n'existe
- **Comment le lire** — là où la ligne noire et les points rouges sont proches, le dénominateur est solide et la tendance fiable ; lisez ensuite la direction — en hausse, stable ou en baisse
- **À surveiller** — une couverture **supérieure à 100 %** est un signal d'alerte (dénominateur trop bas ou comptage gonflé), pas une vraie sur-couverture

Le même graphique est produit aux niveaux national, régional et district — lisez-les ensemble : une tendance nationale saine peut masquer un district en difficulté.